

Қалқанша без патологиясындағы операциядан кейінгі кезеңдегі кардиологиялық асқынулар

Масадыков А.С., Мусин А.М., Танатова З.А., Гарипова А.Р.

Семей қаласы Өңірлік онкологиялық диспансері. Семей мемлекеттік медициналық университеті

Қалқанша без патологиясындағы операциядан кейінгі кезеңдегі кардиологиялық асқынулар

А.С. Масадыков, А.М. Мусин, З.А. Танатова
А.Р. Гарипова

Зерттеу мақсаты - АГ таралуы және АГ деңгейі мен бірге жүрек ишемиялық ауруының (ЖИА) жиілігі, сонымен қатар, қалқанша безінің түйінді патологиясымен байланысты жасалған операциялар көлемінің тәуелділігіне баға беру. Қалқанша безінің түйінді патологиясы бар хирургиялық жолмен емделген, сонымен қатар, қалқанша безінің паренхимасын алуымен байланысты операциядан кейінгі дамыған гипотиреозы бар 295 науқас адам тексерілген. Нәтижесінде тексерілген пациенттерде толық және субтотальді тиреоидэктомиядан кейін жиі артериальды гипертензияның дамуы, қанында холестерин деңгейі және қанның атерогенді потенциалы, сонымен қатар ЖИА даму мүмкіндігінің жоғарлауы анықталған.

Қалқанша бездің қызметтік статусының бұзылуы ағзадағы оның шектеулі қызметіне қарамастан (энергетикалық және басқа да алмасу түрлерін реттеуге қатысатын тиреоидты гармондар шығару), ортақ күшіндегі оның барлық метаболиялық процестерге әсері түрлі органдар мен ағза жүйесі жағдайларының өзгеруін туғызады. Олар әйелдердегі репродуктивті жүйе патологиясы деңгейінде көрінеді [1, 2], семіздік [3], сүйек тіні метоболизімінің өзгеруімен оның минералды тығыздығының төмендеуі [4], респираторлық жүйе аурулары [5], асқазан - ішек жолдары [6]. Созылмалы гипотиреоз клиникасында жүрек - қан тамырлар жүйесі патологиясы анағұрлым жиі көрінеді, оның өзінде артериалды қан қысымының жоғарылауы алдыңғы қатарға шығады.

Қалқанша бездің зардапсыз және қатерлі түйінді патологиясы барысындағы операция көлеміне артериалды қан қысымы деңгейінің тәуелділігін талдау бүгінгі күнге дейін сирек жүргізілді және оның нәтижелері қарама - қарсы күйінде қалып отыр.

Сондай-ақ артериалдық қан қысымының жоғарылауы жүрек-қан тамырларының басқа да әртүрлі ауруларының даму қауіпінің негізгі факторларының бірі болып табылатыны белгілі, оның ішінде ЖИА (ИБС) [7]. Гипотиреоз барысындағы аталмыш патология жоғарылау жиілігіне ықпал ететін екінші фактор холестеринді алмасудың бұзылуының дамуы болып табылады [8].

Зерттеудің мақсаты

— қалқанша бездің түйінді патологиясы бар науқастардағы операция көлеміне АГ таралу, артериалдық қан қысымы деңгейі мен ЖИА даму жиілігіне тәуелділігін бағалау.

Материалдар мен әдістер

Хирургиялық емге жатқан қалқанша бездің әртүрлі (түйінді) патологиясымен - 295 науқас тексерілді, оның

Cardiologic Complications In Postsurgical Period Of Patology Of Thyroid Gland.

A.S.Masadykov, A.M.Musin, Z.A.Tanatova,
A.R.Garipova

Research objective is estimation of dependence of prevalence AG, level of arterial pressure and frequency of development HCD at sick of a central pathology of a thyroid gland from operation volume. 295 patients with a various central pathology of the thyroid gland, exposed to surgical treatment, including accompanied by removal of thyroid gland parenchyma and development postoperative hypothyroidism are surveyed. The raised frequency of development of an arterial hypertension at surveyed, patients, increase in the maintenance of cholesterol in blood and atherogenic blood potential, and also increase of risk of HCD development after total and subtotal thyroidectomy is revealed.

ішінде - 40 науқасқа склероздаушы ем жүргізілді, ал қалқандарына хирургиялық операция жасалды: тотальды тиреоидэктомия - 29 науқасты, субтотальды тиреоидэктомия - 35 жағдайда, гемитиреоидэктомия - 84 жағдайда, гемитиреоидэктомия склероздаушы еммен үйлестіріле - 35 пациентке және орган сақтаушы көлемді операция гемитиреоидэктомия кемінде - 72 науқасқа жасалды.

Зерттеуге анамнезге қосқандағы тексеру сәтінде қалқанша без патологиясының клиникалық белгілері бақылау тобын негізгі жас ерекшелігі және жыныстық құрамы бойынша онша айырмашылығы жоқ денсаулығы дұрыс - 50 пациент құрады.

АҚҚ анықтау бір апта бойы жүргізіліп, Коротков әдісі бойынша үш рет анықтап, үш рет тексеру жолымен жүзеге асырылды.

Жүрек-қан тамырлары асқынулары дамуының қауіп факторы ретінде қан құрамындағы холестерин автоматты биохимиялық талдағыштағы липопротеидті фракция зерттелді.

Коронарлы қан ағысының адекваттылығын талдау «кардиотехника» (РФ) фирмасының автоматты құрылғысында Холтер бойынша жүктемелі сынамаларды жүзеге асыру мен ЭКГ тәуліктік компьютерлі мониторинг жүргізу жолымен жүзеге асырылды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау

Қалқанша безге операция жасалғаннан кейін науқастардағы қан тамыры жүйесінің өзгеру сатысын сипаттайтын негізгі параметр ретінде АҚҚ жоғарылау деңгейі зерттелді.

АҚҚ қалқанша безге жасалған операция көлеміне тәуелділігін бағалау үшін операциядан кейінгі кезеңдегі тексерілген науқастар 3 топқа бөлінді: АҚҚ дұрыс жас ерекшелігі тобы, шекаралы гипертензиямен және оның клиникалық гипертензиясымен.

Салыстырмалы зерттеу басқа көрсеткіштерді бағалау

1 – кесте. Қалқанша безге операция жасалып, тексерілгендердегі артериалдық қысымының өзгеруіне сипаттама

Тексерілгендер тобы	АҚ 130/85 мм рт.ст. төмен		АҚ 131/86-145/90 мм рт.ст. шегінде (шек аралы гипертензия)		АД 146/91 мм рт.ст. жоғары (гипертензия)		АҚ орташа деңгейі (САД/ДАД), мм рт.ст.
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Бақылау, n=50	31	62,0±6,9	12	24,0±6,0	7	14,0±4,9	127±5/76±2
Тотальды тиреоидэктомия, n=29	12	41,4±9,1	9	31,0±8,6	8	27,6±8,3	149±7*/88±3*
Субтотальды тиреоидэктомия, n=35	17	48,6±8,4	11	31,4±7,8	7	20,0±6,8	145±5*/85±3*
Гемитиреоидэктомия, n=84	45	53,6±5,4	25	29,8±5,0	14	16,7±4,1	139±5/82±3
Гемитиреоидэктомия склероздаушы еммен үйлестірілген, n=35	19	54,3±8,4	12	31,4±8,0	4	11,4±5,4	139±6/81±2
Орган сақтаушы операциялар, n=72	41	56,9±5,8	20	27,8±5,3	11	15,3±4,2	130±5/78±2
Склероздаушы терапия, n=40	25	62,5±7,7	9	22,5±6,6	6	15,0±5,6	129±5/76±2
Ескерту - * - бақылау тобы көрсеткіштерімен айырмашылық нақты, p<0,05							

2 Кесте – Қалқанша безге жасалған операция категориясына байланысты холестерин құрамының орташа мәні мен оның липопротеидты фракциясы

Тексерілгендер тобы	ОХС, мм/л	ХС ЛПНП, мм/л	ХС ЛПВП, мм/л	ХСЛПНП/ХС ЛПВП, мм/л
Бақылау, n=50	3,55±0,17	2,07±0,15	1,47±0,11	1,41±0,09
Тотальды тиреоидэктомия, n=29	5,31±0,36*	3,72±0,23**	1,59±0,12	2,34±0,15**
Субтотальды тиреоидэктомия, n=35	4,87±0,29*	3,30±0,18**	1,57±0,10	2,10±0,12*
Гемитиреоидэктомия, n=84	4,25±0,21*	2,69±0,11*	1,56±0,14	1,72±0,10*
Гемитиреоидэктомия склероздаушы терапиямен үйлестіруші, n=35	4,17±0,19*	2,59±0,14*	1,58±0,12	1,64±0,09
Орган сақтаушы операциялар, n=72	3,96±0,22	2,43±0,13	1,53±0,13	1,59±0,11
Склероздаушы терапия, n=40	3,68±0,18	2,23±0,13	1,45±0,10	1,54±0,11
Ескерту - * - Бақылау тобымен айырмашылық нақты, p<0,05, ** - p<0,01				

3 – кесте. Қалқанша бездің түйінді патологиясы хирургиялық жолмен емделген науқастардағы және бақылау тобындағы ЭКГ мониторинг нәтижелері.

Тексерілгендер тобы	Ишемия эпизодтары жоқ		Ишемия эпизодтары бар					
			ФКІ жүктемесі деңгейінде		ФКІІ жүктемесі деңгейінде		ФКІІІ-ІV жүктемесі деңгейінде	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Бақылау, n=50	7~46~	92,0±3,8	3	6,0±3,4	1	2,0±2,0	0	-
Тотальды тиреоидэктомия, n=29	7~22~	75,9±6,1*	4	13,8±4,9	1	3,4±2,6	2	6,9±3,6
Субтотальды тиреоидэктомия, n=35	7~28~	80,0±5,7	5	14,3±4,9	2	5,7±3,3	0	-
Гемитиреоидэктомия, n=84	74	88,1±4,6	8	9,5±4,2	1	1,2±1,2	1	ГТ2±ЦГ
Гемитиреоидэктомия склероздаушы терапиямен үйлестірілген, n=35	32	91,4±4,0	2	5,7±3,3	1	2,9±2,4	0	«1
Орган сақтаушы операциялар, n=72	Г66Н	91,7±3,9	4	5,6±3,2	2	2,8±2,3	0	-
Склероздаушы терапия, n=40	37	92,5±3,7	2	5,0±3,1	1	2,5±2,2	0	-
Ескерту - * - Бақылау тобымен айырмашылық нақты, p<0,05								

барысындағы сол бақылау тобына қатысты жүргізілді.

Алынған деректер 1 - кестеде берілген

1 - кестеден көріп отырғанымыздай, тотальды тиреоидэктомия жасалған науқастар арасында шекаралы гипертензиясы бар адамдар саны біршама артты және әртүрлі сатыдағы клиникалық манифестерленген гипертензиясы бар адамдар анағұрлым көп (2 есеге дерлік).

Аталмыш топта артериалды қан қысымы көрсеткіштерінің нақты жоғарылауы болды (p<0,05 систолалық көрсеткіш сияқты диастолалық АҚҚ). Субтотальды тиреоидэктомия барысында артериалды қан қысымының дұрыс мәні бар адамдар санына қатысты төмендеуі гипертензия жағдайындағы төмен сан есебінен қалыпты болды. Бірақ АҚҚ орташа мәні осы топта да бақылаудағыдан асып кетті (p<0,05).

Гемитиреоидэктомияда, оның ішінде склероздаушы еммен үйлестіруде АҚҚ жоғарылау жағдайының саны бақылау тобындағыдан қалыпты артты, айырмашылық нақты емес. Орган сақтаушы операция мен склероздаушы ем жүргізу

барысында артериалды гипертензия жағдайының саны бақылау деңгейінен артқан жоқ.

Орган сақтаушы операциялар мен склеротерапияның барлық нұсқаларында АҚҚ систолалық және диастолалық деңгейі бойынша айырмашылық байқалмады. Әдебиеттегі белгілі холестерин құрамы мен қан атрогенділігінің жоғарылауы (ХС липопротеидты фракциясының концентрациясына қатынасы

бойынша). 2 - кестеде бейнеленгендей біздің зерттеуімізде де анықталды.

Алынған деректерден холестериннің жалпы деңгейінің анағұрлым жоғарылығы біз күткендей тотальды тиреоидэктомиядан кейін қалқанша без қызметінің анағұрлым төмендеуі байқалды. Бұрын көрсетілгендей орынбасушы ем жүргізу нәтижесінде оның компенсация деңгейі (сатысы) сол бұрынғыдай төмен болды. Бақылау тобымен холестериннің жалпы құрамы бойынша айырмашылық - 49,6 % (p<0,05) құрады.

Екінші сәт, операциядан кейінгі гипотиреозды науқастарда холестеринді метоболизм жағдайын анағұрлым жоғары жағдайда сипаттады – жоғары тығыздықтағы холестерин липопротеидтері құрамында маңызды өзгерістердің болмауы тексерілген топтардың бірде - бірінде көрсеткіш бойынша бақылау тобымен айырмашылық байқалған жоқ. Сонымен жалпы холестерин құрамының артуы оның төмен тығыздықтағы липопротеидтердегі атрогенді транспорттық фракциядағы ұлғаю есебінен іске асты.

Сонымен, тотальды тиреоидэктомиядан кейін тексерілгендер тобы бойынша соңғы көрсеткіштің арту сатысы орташа бақылау тобына қатысты - 79,7 % құрады (p<0,05). Сау адамдар деңгейінің күрт артуы - 66,1% (p<0,01) құраған холестериннің липопротеидті фракция құрамының қатынасы бойынша анықталды.

Субтотальды тиреоидэктомия барысында жалпы холестерин құрамының бақылаудан артуы - 37,2 % (p<0,05)

жетті, холестеринді фракция ЛПНП – 59,4 % ($p < 0,01$) ХС ЛПНП/ХС қатынасы ЛПВП 49,3 % ($p < 0,05$).

Қалқанша без паренхимасының кішкене бөлігін сақтап қалу барысында холестерин құрамы бойынша бақылау тобымен нақты, әрі маңызды айырмашылықтар анықталды.

Сонымен, гемитиреоидэктомия барысында - 30,4 % ($p < 0,05$) құраған ХС ЛПНП абсолютті құрамының артуы анағұрлым анық болды. Жалпы холестерин концентрациясы бойынша және холестериннің липопротеидті фракциясының қатынас деңгейі бойынша нақты айырмашылықтар болды.

Орган сақтаушы операция мен склероздаушы ем жүргізгенде қандағы холестерин құрамы өзгерген жок. 3 - кестеде тексерілген науқастармен бақылау тобындағы компьютерлік мониторинг ЭКГ талдауы нәтижелері берілген ST аралық ишемиялық өзгерістер эпизодтары мониторинг мен велоэргометрия барысында болмаған адамдар жиілігінің төмендеуі қалқанша бездің қызметін атқарушы үлкен көлемді паренхимасын алып тастау барысында ғана байқалды, яғни тотальды және субтотальды тиреоидэктомия тобында.

1 жағдайда аталмыш өзгерістер нақты болды (17,5 % ($p < 0,05$)). Қалған барлық жағдайда ишемия эпизодтарының жиілігі бойынша нақты айырмашылық немесе ишемиялық өзгерістердің болмауы тіркелмеді.

Сонымен, алынған деректерден тиреоидты гормондардың экзогенді өнімінің толық тоқтатылуы анық мүмкіндікте артериалды гипертензия дамуының қауіп фак-

торларына және әсіресе ЖИА жатқызылуы мүмкін. Осы топтағы науқастар орын басушы емді тағайындау мен оның тиімділігін бақылауда баса назар аударуды талап етеді.

Әдебиеттер

1. Валдина Е.А. Заболевания щитовидной железы. -СПб.: Питер, 2001.-416 с.
2. Бубнов А.Н., Кузьмичёв А.С., Гринёва Е.Н., Трунин Е.М. Заболевания щитовидной железы. Часть I. Узловой зоб. - СПб., 2002. - 96 с.
3. Aghini-Lombardi F., Antonangeli L., Martino E. et al. The spectrum of thyroid disorders in an iodine-deficient community: the Pescopagano survey // Clin. Endocrinol. Metab. -1999. - Vol.84, №2. - P.561-566.
4. Consensus development conference: prophylaxis and treatment of osteoporosis // Osteoporosis Int. —1991 -№1.-P.114-117.
5. Талантов В.В. Маски гипотиреоза в общеврачебной практике // Тезисы докладов 3-й Всероссийской научно-практической конференции. - Пермь, 2000. -С.152-153.
6. Аристархов В.Г., Фурсова А.А., Донюкова А.И., Аристархов Р.В. Послеоперационный гипотиреоз у больных узловым коллоидным зобом // Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы X (XII) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. - Смоленск, 2002. - С.20-21.
7. Строганова И.П., Ильяш М.Г. Артериальная гипертензия как прогностический фактор течения ишемической болезни сердца // Тер. архив. - 1992. - №3. -С.84-86.
8. Ghelase F., Georgescu I., Ghelase S. et al. Present strategies in the diagnosis and treatment of thyroid diseases // Chirurgia. - 2001. - Vol.96(4). - P.355-365.